

Physioguide — Clínica — Túnel radial / PIN vs LET

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Status: ACTIVE (Phase 1)

Evidence: Maudsley, supinación resistida, palpación arcade of Frohse; cluster C

Principles: Master clinical document

1. DEFINITION

Síndrome del túnel radial = dolor en antebrazo proximal dorsal por irritación del nervio radial / ramo interóseo posterior (PIN) a nivel del supinador (arcade of Frohse), sin (o con poco) déficit motor.

PIN clásico = más motor (extensión de dedos/muñeca, desviación radial por ERC conservado).

Ambos se solapan con LET porque Maudsley y Cozen cargan ECRB y el túnel radial.

2. DISCRIMINACIÓN CLÍNICA

- Hallazgo — LET !' — Túnel radial / PIN !'
 - Dolor máximo — Epicóndilo óseo — Antebrazo proximal dorsal
 - Palpación — Epicóndilo / ECRB — Arcade of Frohse / supinador
 - Maudsley — Dolor en hueso — Dolor muscular proximal
 - Déficit extensión dedos — No — PIN
 - Cuello / Spurling — C6–C7 — C6–C7 también
-

3. CLUSTER

DOLOR ANTEBRAZO PROXIMAL DORSAL > EPICÓNDILO
+ PALPACIÓN SOBRE TÚNEL RADIAL
± MAUDSLEY / COZEN CON DOLOR NO ÓSEO
± SUPINACIÓN RESISTIDA DOLOROSA
SIN (túnel) O CON (PIN) DEBILIDAD DE EXTENSORES
!' NEURAL RADIAL COMPATIBILITY !'
SIEMPRE CRIBAR CUELLO

4. AI RULES

- Maudsley positivo no significa nervio radial lesionado.
- LET y túnel radial pueden coexistir.
- Debilidad franca de extensión de dedos !' PIN / C7, no “tendinitis”.
- No inventar Sn/Sp.

Citation: Literatura radial tunnel vs LET (solapamiento conocido). Zwerus elbow exam. Coombes LET BJSM (modelo tendinoso local).

